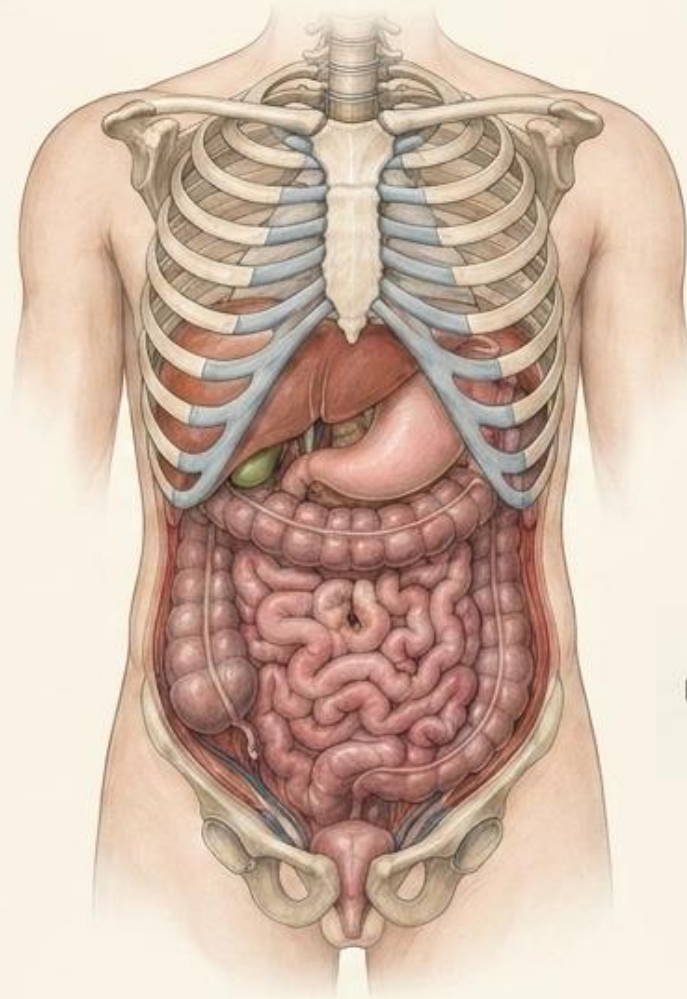


L'Intestin Grêle

Anatomie, Physiologie et Réflexologie Occipito-Podale (ROP)



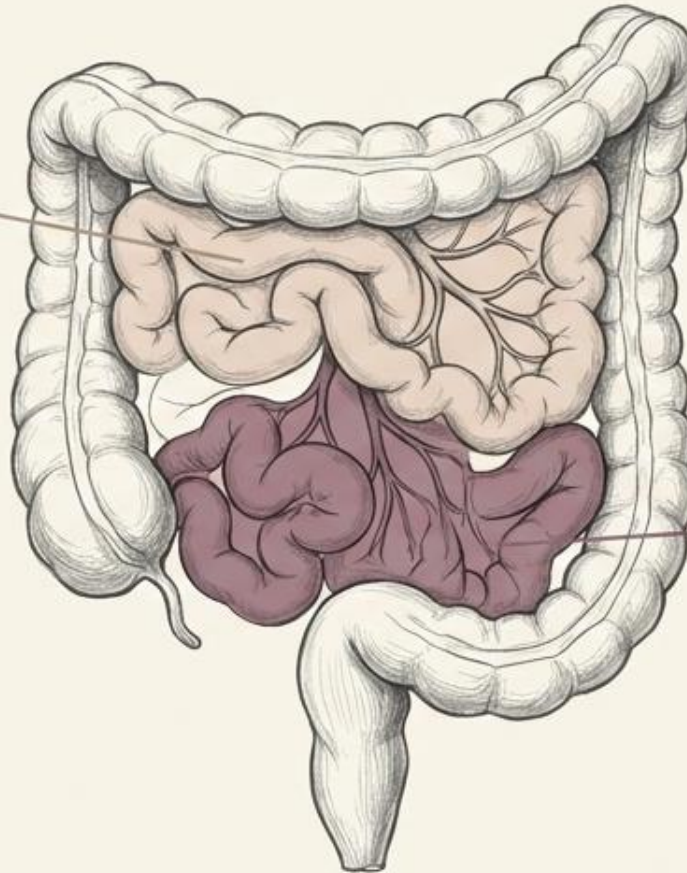
Organe le plus long du corps (6 à 7 mètres post-mortem, rétracté in vivo par le tonus musculaire), s'étendant du pylore à la valvule iléo-cæcale.

Topographie : L'intestin grêle au sein du cadre colique

Le **jéjunum-iléum** (6 à 7 mètres sur le cadavre) comporte 15 à 16 anses intestinales réparties en deux groupes fonctionnels distincts.

Jéjunum

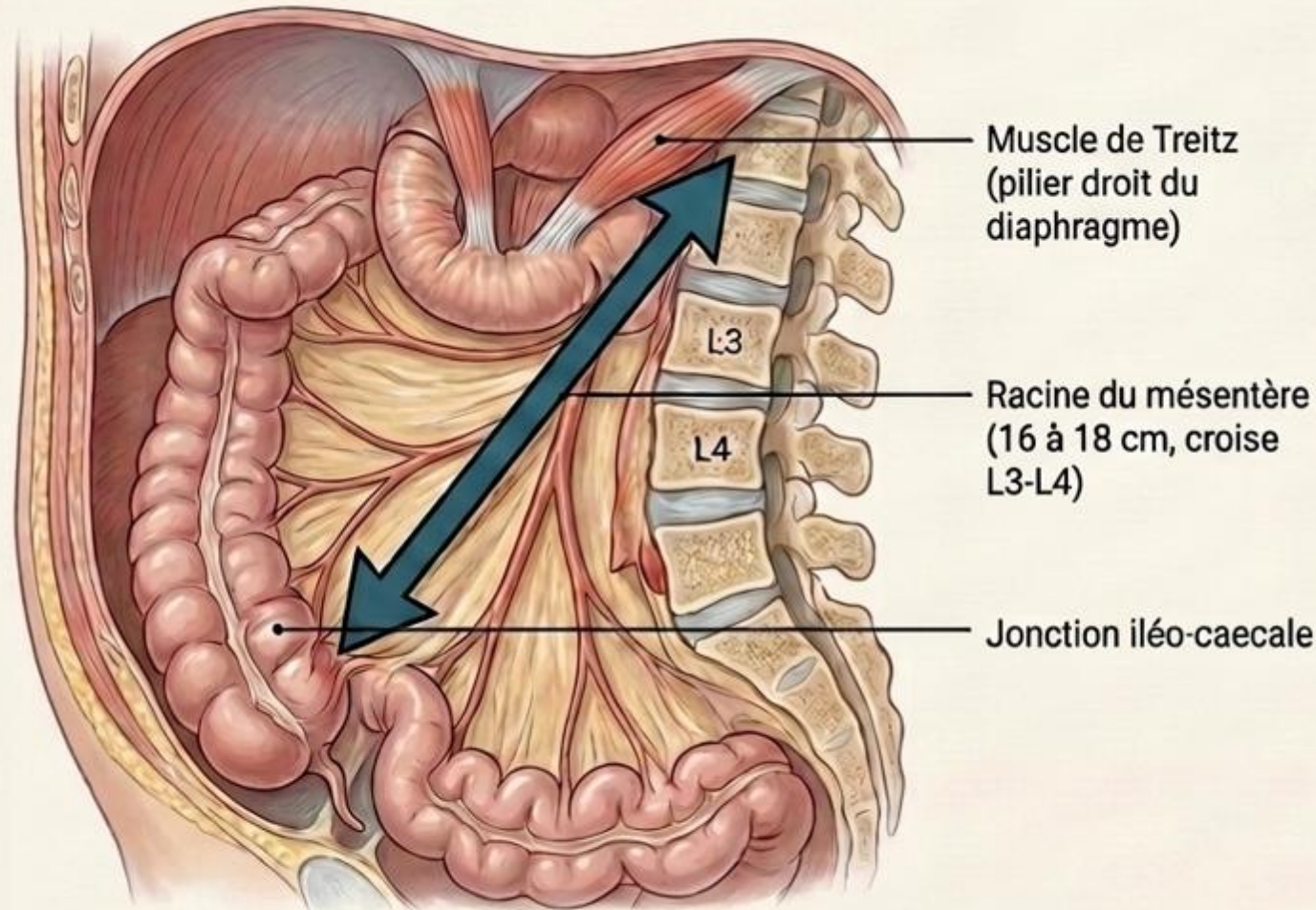
- **Localisation** : Quadrant supérieur gauche.
- **Orientation** : Anses et système vasculaire orientés horizontalement.
- **Rapports** : Recouvre le côlon descendant.
- **Caractéristiques** : Groupe généralement plus développé.



Iléum

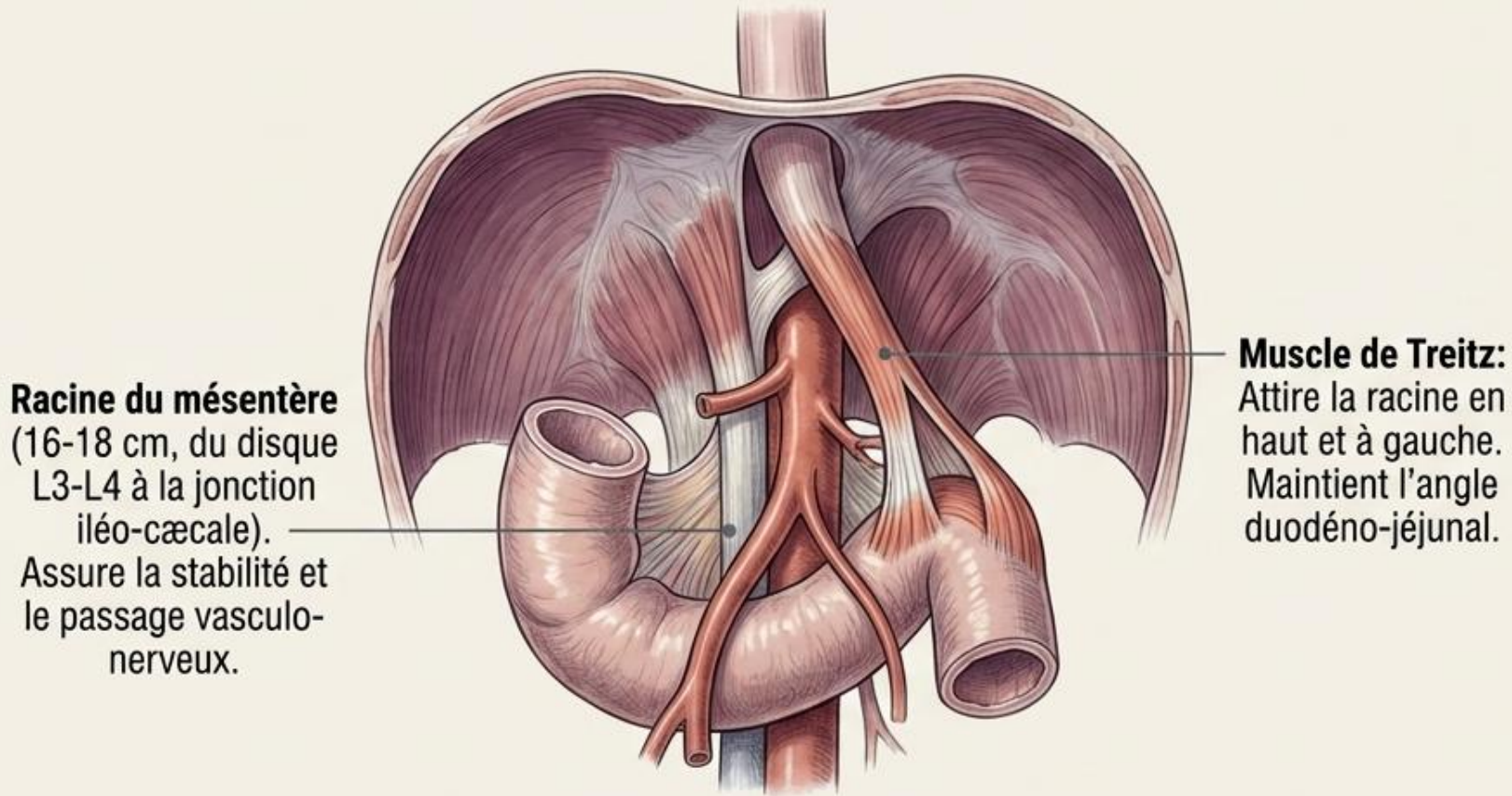
- **Localisation** : Quadrant inférieur droit.
- **Orientation** : Anses et système vasculaire orientés verticalement.
- **Rapports** : Laisse libre le côlon ascendant.

Le mésentère et sa mécanique de suspension



Le mésentère est un repli à double feuillet du péritoine reliant l'intestin grêle à la paroi abdominale postérieure ; il contient les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs destinés à l'intestin

Suspension et Mécanique Intestinale



Le muscle de Treitz favorise une tension longitudinale indispensable à l'évacuation du contenu duodénal.

Intérêt en ROP

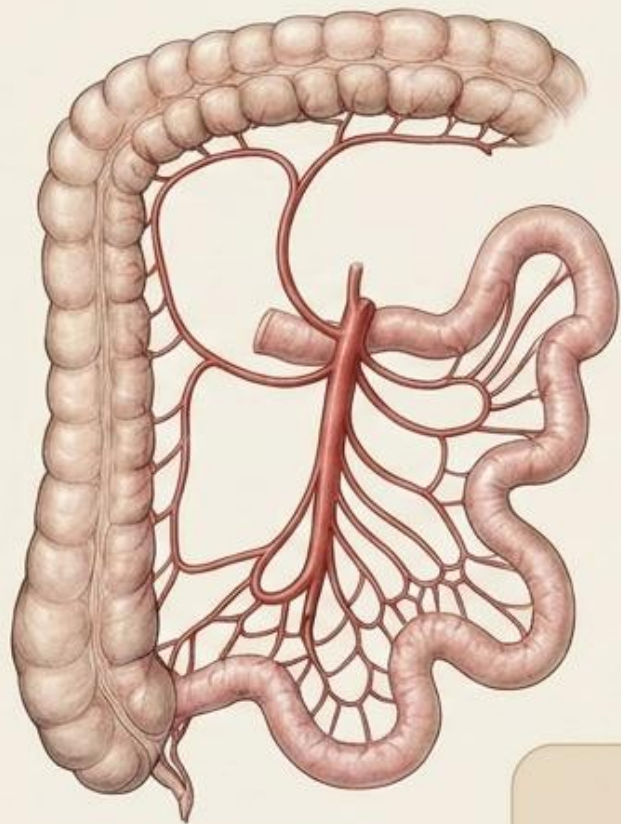
Le Syndrome de la Pince Aorto-Mésentérique (Nutcracker Syndrome)

La perte de tension longitudinale peut entraîner une compression du 4^e duodénum et de la veine rénale gauche entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure (AMS), provoquant un retard d'évacuation et un risque de reflux gastro-duodénal.

Action: La racine du mésentère est hautement réflexogène en ROP.

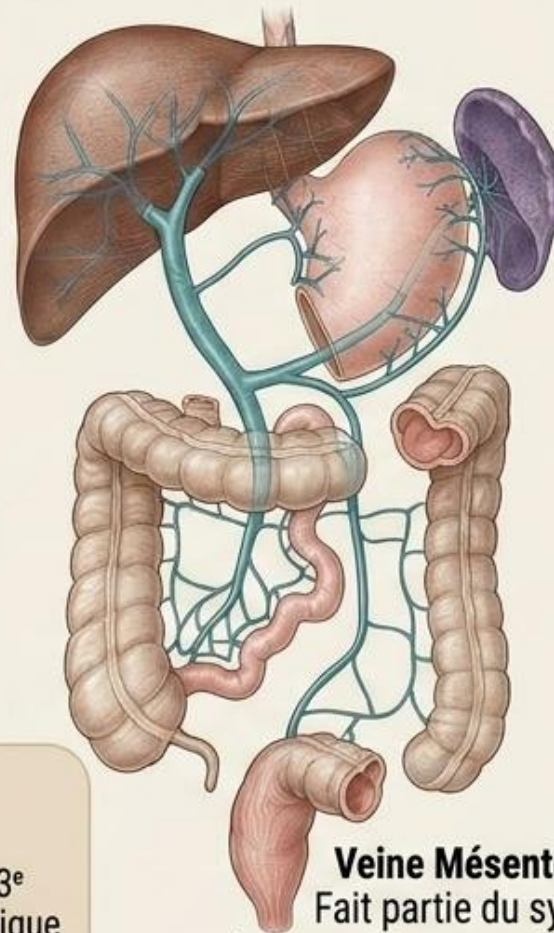
L'Axe Vasculaire et le Système Porte

Apport Artériel



Artère Mésentérique Supérieure (AMS):
Naît sous le tronc coeliaque (Th12-L1).
Irrigue l'intestin grêle, côlon ascendant
et 2/3 du transverse.

Drainage Veineux



Veine Mésentérique Supérieure:
Fait partie du système porte. Draine
le sang riche en nutriments directement
vers le foie pour traitement métabolique.

Intérêt en ROP

Le Pouls Mésentérique: Perceptible au niveau du 3^e
duodénum (à droite de l'ombilic). C'est un repère clinique
vasculaire majeur lors de la palpation abdominale.

Le Réseau Lymphatique et Immunitaire

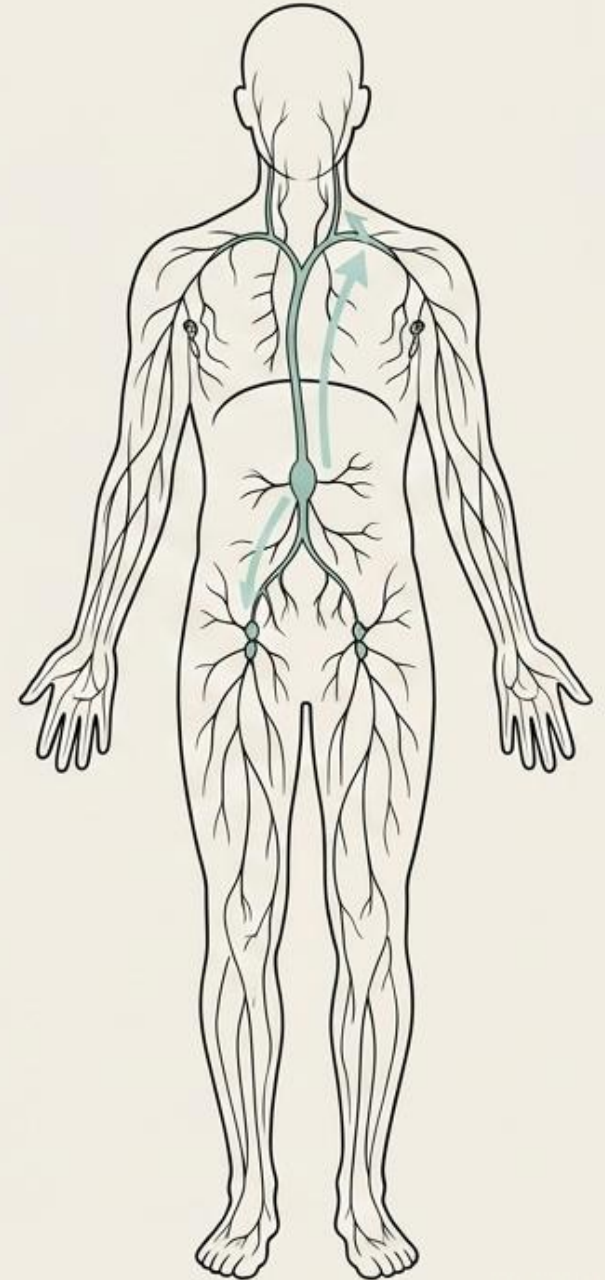
1. **Capillaires chylifères:** Absorption intestinale.
2. **Citerne de Pecquet (Citerne de chyle).**
3. **Conduit thoracique:** Remontée trans-diaphragmatique.
4. **Carrefour jugulo-subclavier gauche:** Retour dans la circulation sanguine.

L'exception métabolique

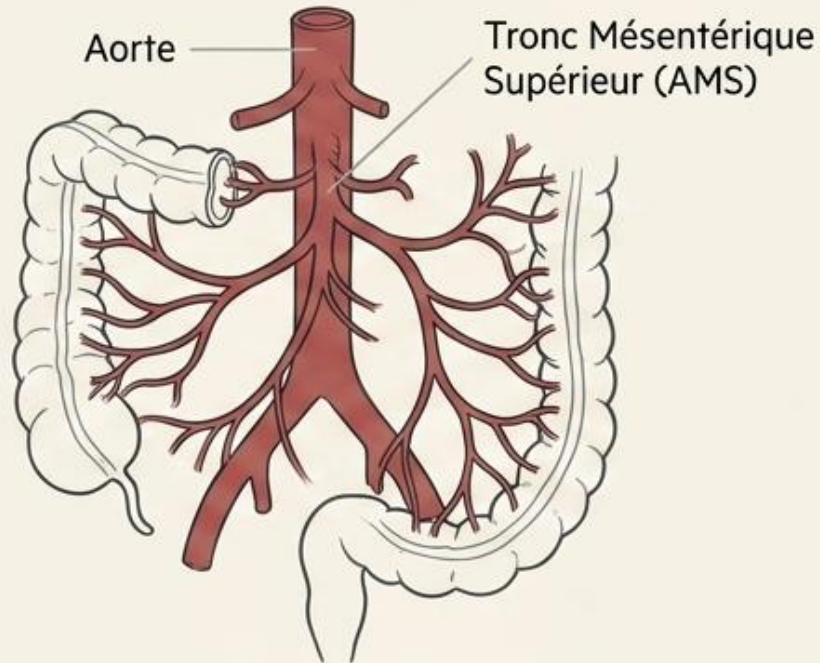
Contrairement aux glucides et protéines qui passent par le foie (veine porte), les lipides (chaînes longues) et les vitamines liposolubles (A, D, E, K) bypassent le foie et rejoignent directement le système lymphatique.

Intérêt en ROP

Soutenir le foie et le système lymphatique par action réflexe optimise la qualité de l'absorption lipidique et l'immunité globale.

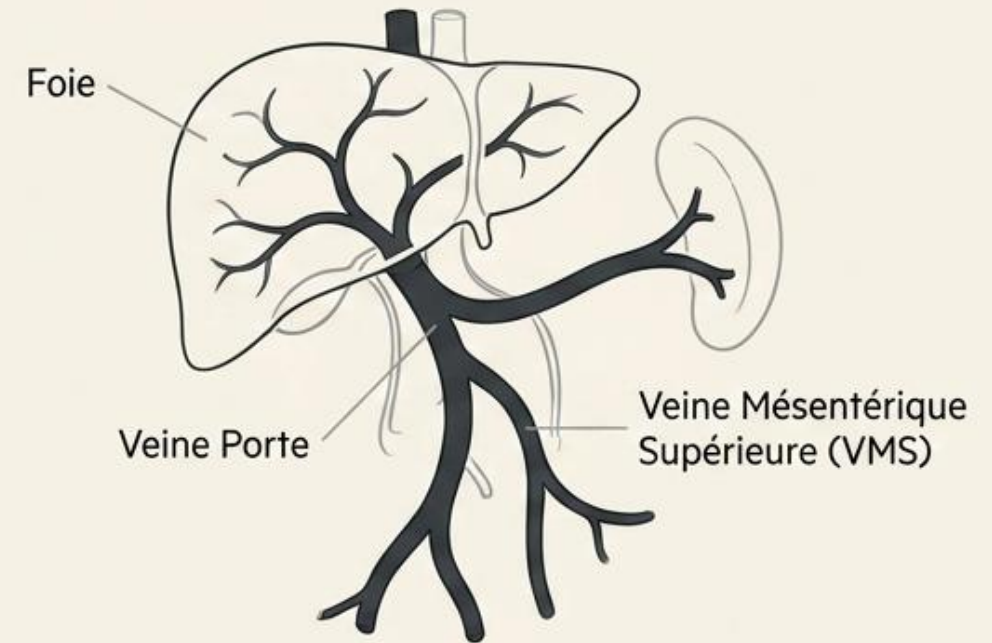


L'axe de l'irrigation et du drainage : Tronc Mésentérique Supérieur



Apport Artériel (Artère mésentérique supérieure)

- Origine : Disque Th12-L1 (sous le tronc cœliaque)
- Irrigue l'intestin grêle, le côlon ascendant et les 2/3 proximaux du transverse



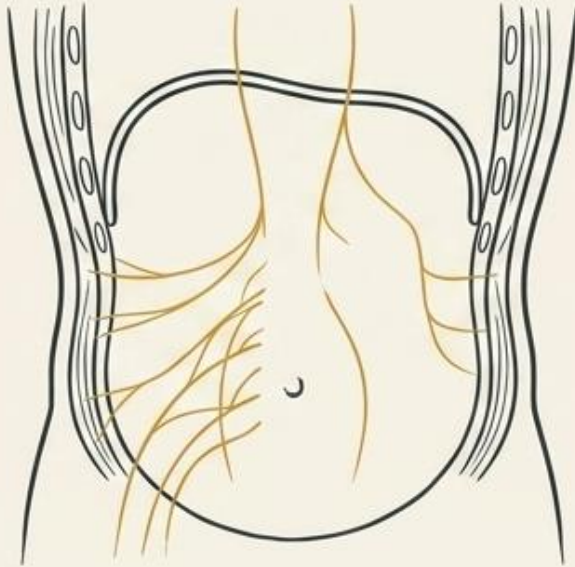
Drainage Veineux (Système Porte)

- Transporte le sang veineux chargé des nutriments absorbés directement vers le foie pour détoxification et métabolisation.

Note Pratique : Le pouls de l'AMS est perceptible au niveau du 3ème duodénum, à droite de l'ombilic.

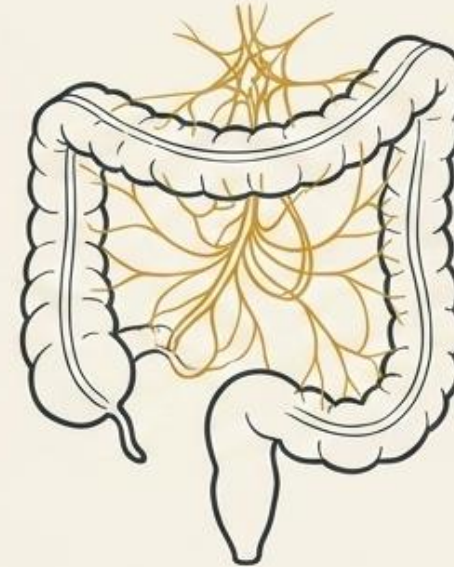
La double réalité neurologique du péritoine

Péritoine Pariétal (Innervation Somatique)



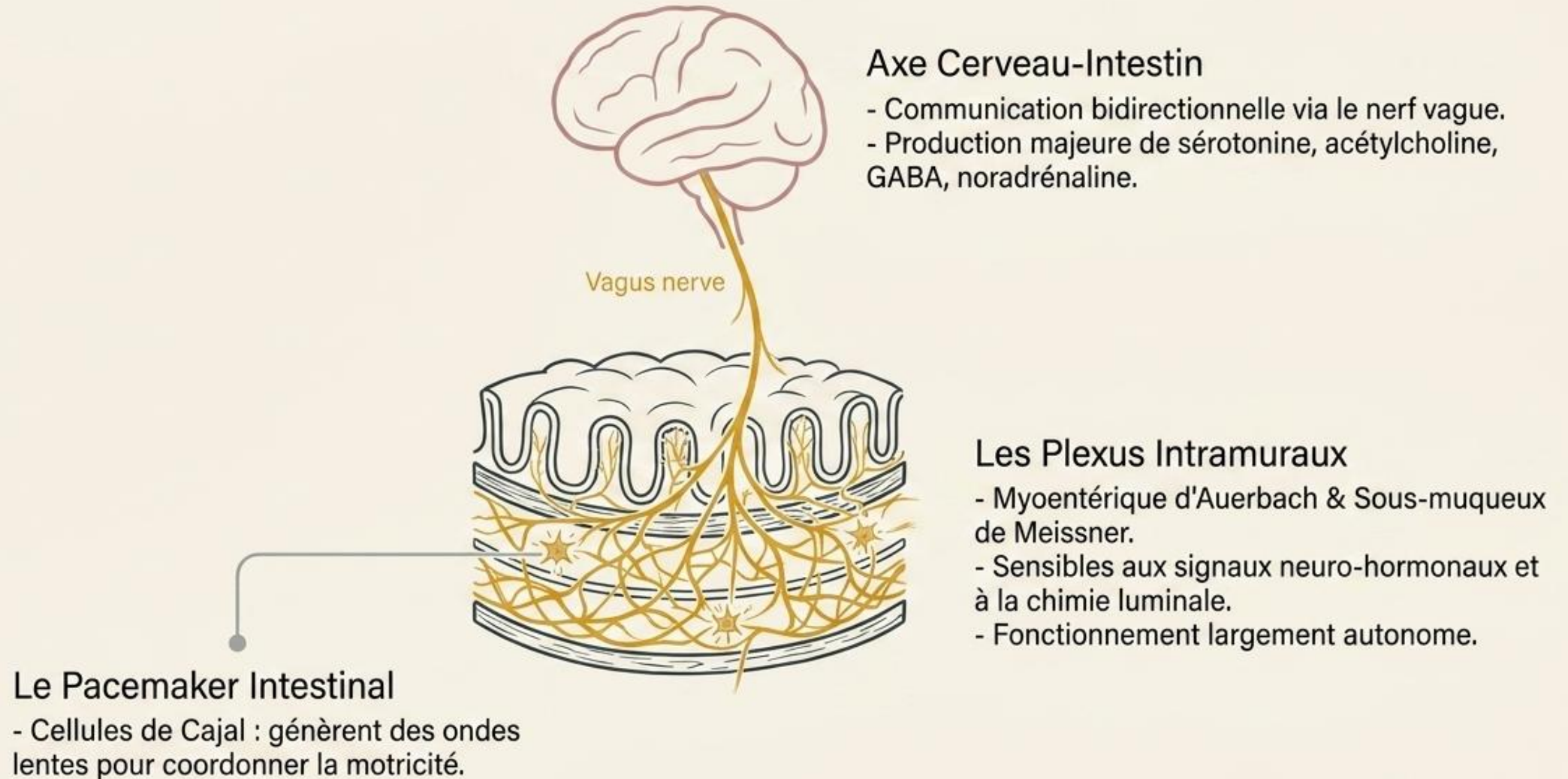
- Voies : Nerfs phréniques, 6 derniers intercostaux, plexus lombaire.
- Sensibilité : Aiguë (douleur, pression, température).
- Implication ROP : Projection des douleurs péritonéales vers le système ostéo-musculo-articulaire (cervicales, lombaires, scapulaires).

Péritoine Viscéral (Innervation Autonome)



- Voies : Système Sympathique (Th8-Th11, nerfs splanchniques) et Parasympathique (Nerf Vague).
- Sensibilité : Faible au toucher/section. Stimulée par l'étirement (distension) et la chimie.
- Implication ROP : Le Sympathique inhibe le péristaltisme (stress) ; le Vague le favorise.

Le Deuxième Cerveau : Autonomie du Système Nerveux Entérique (SNE)



Le "Deuxième Cerveau" : Système Nerveux Entérique

Plexus Intra-Muraux

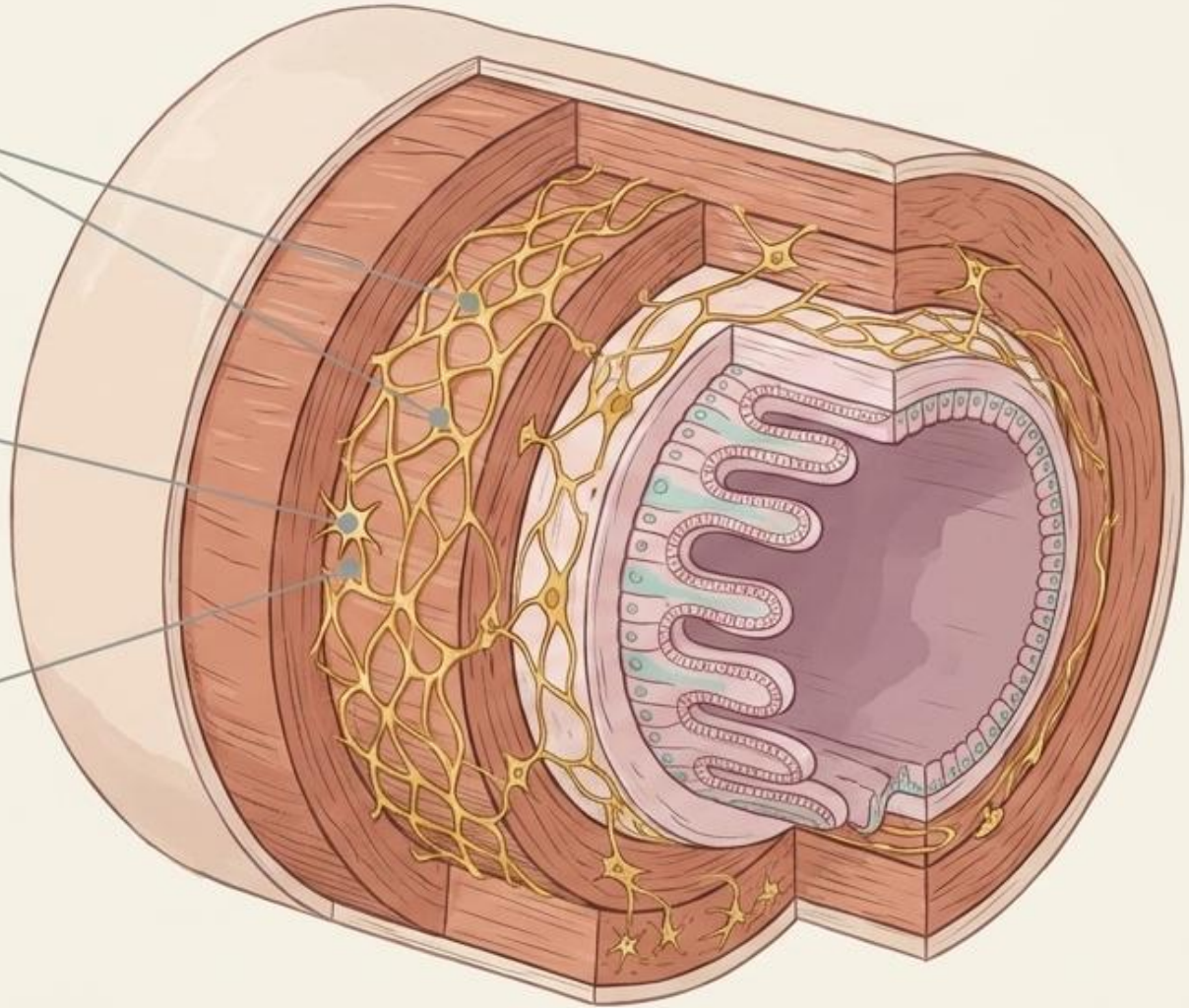
Plexus myentérique d'Auerbach et sous-muqueux de Meissner. Assurent une régulation quasi autonome des fonctions digestives.

Cellules de Cajal

Le pacemaker intestinal. Génèrent des ondes lentes qui coordonnent la motricité indépendamment du péristaltisme induit par le chyme.

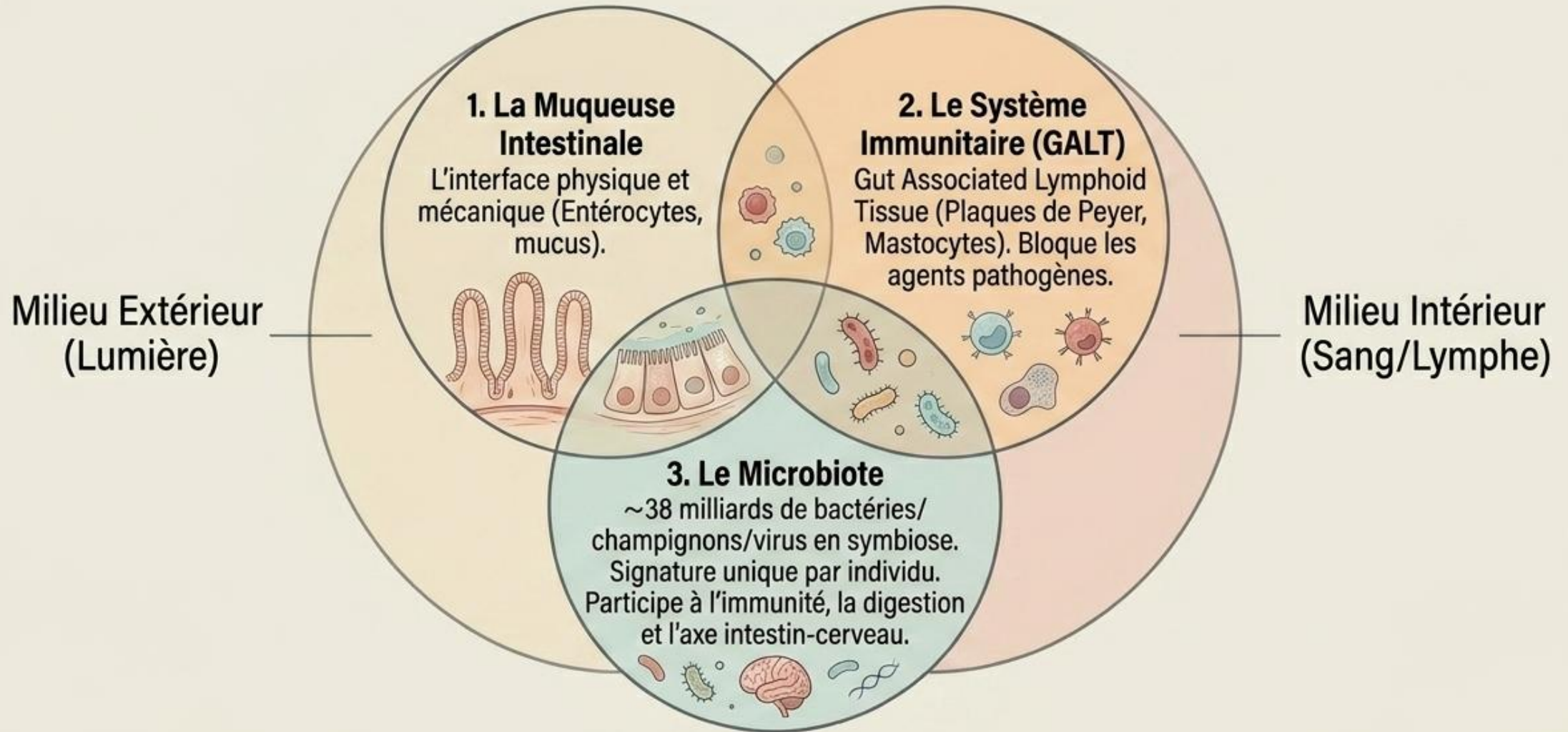
Production Neurochimique

Synthèse majeure de sérotonine (régulation de l'humeur partagée avec le cerveau), d'acétylcholine, de noradrénaline et de GABA.



L'Écosystème Intestinal : Frontière Biologique

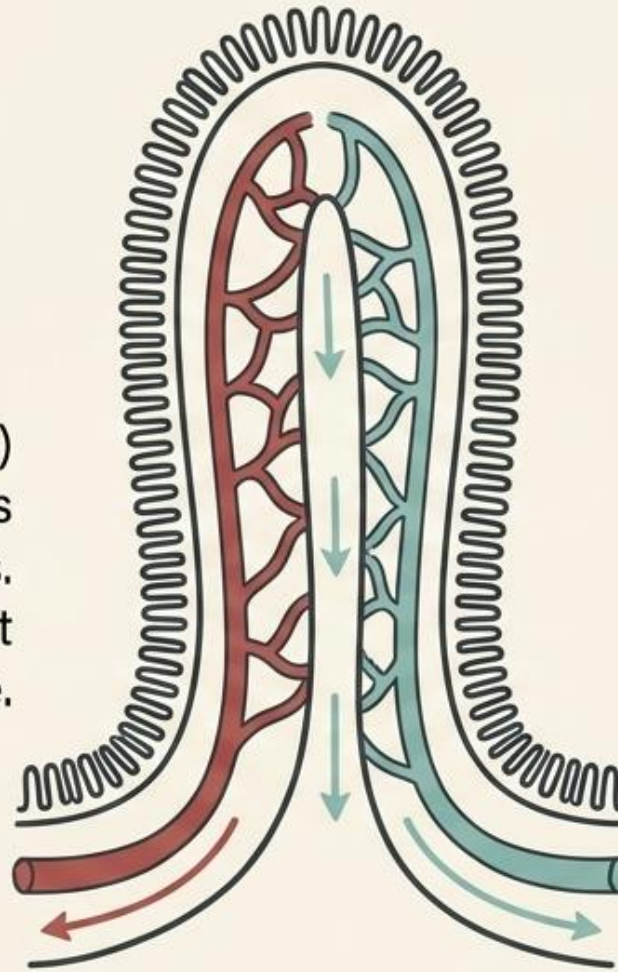
La muqueuse agit comme une barrière sélective et un écosystème complexe régulant l'homéostasie.



La Double Voie d'Absorption Micronutritionnelle

Voie Sanguine (Capillaires)

- Absorbés : Eau, oses simples, acides aminés, vitamines hydrosolubles.
- Destination : Acheminés directement vers le foie via le système porte.



Voie Lymphatique (Chylifères)

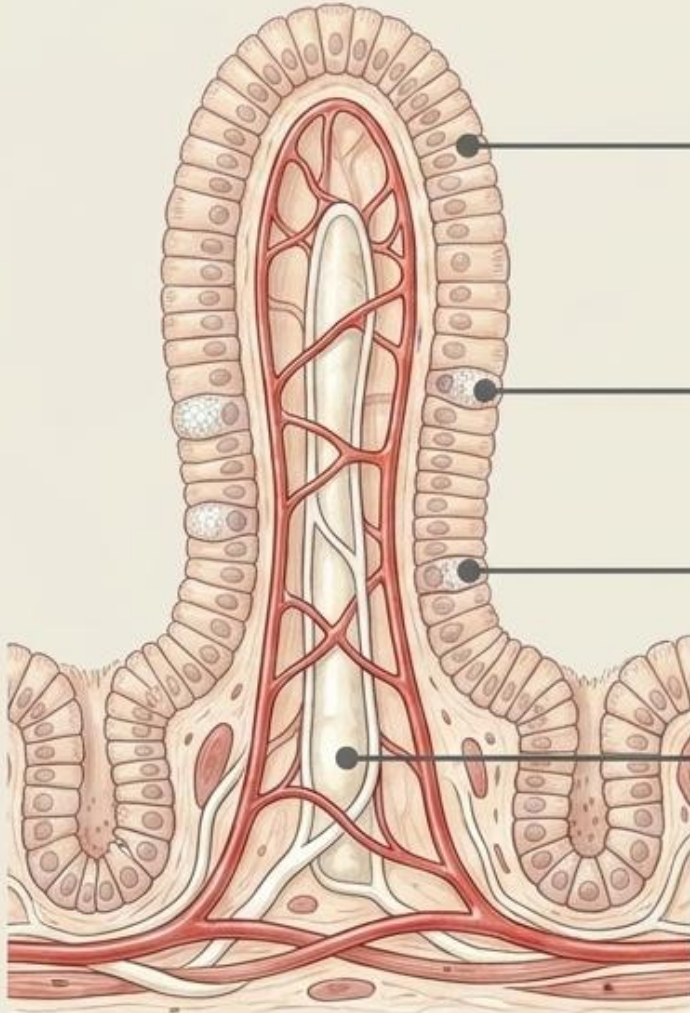
- Absorbés : Graisses, protéines à chaîne longue, vitamines liposolubles (A, D, E, K).
- Destination : Réseau lymphatique -> Citerne de Pecquet -> Canal thoracique.



Intérêt en ROP : Une action réflexe podale sur le foie et le système lymphatique soutient qualitativement l'absorption et l'immunité.

Micro-Anatomie : La Barrière Intestinale

L'intestin grêle étalé possède une superficie d'échange équivalente à un court de tennis.

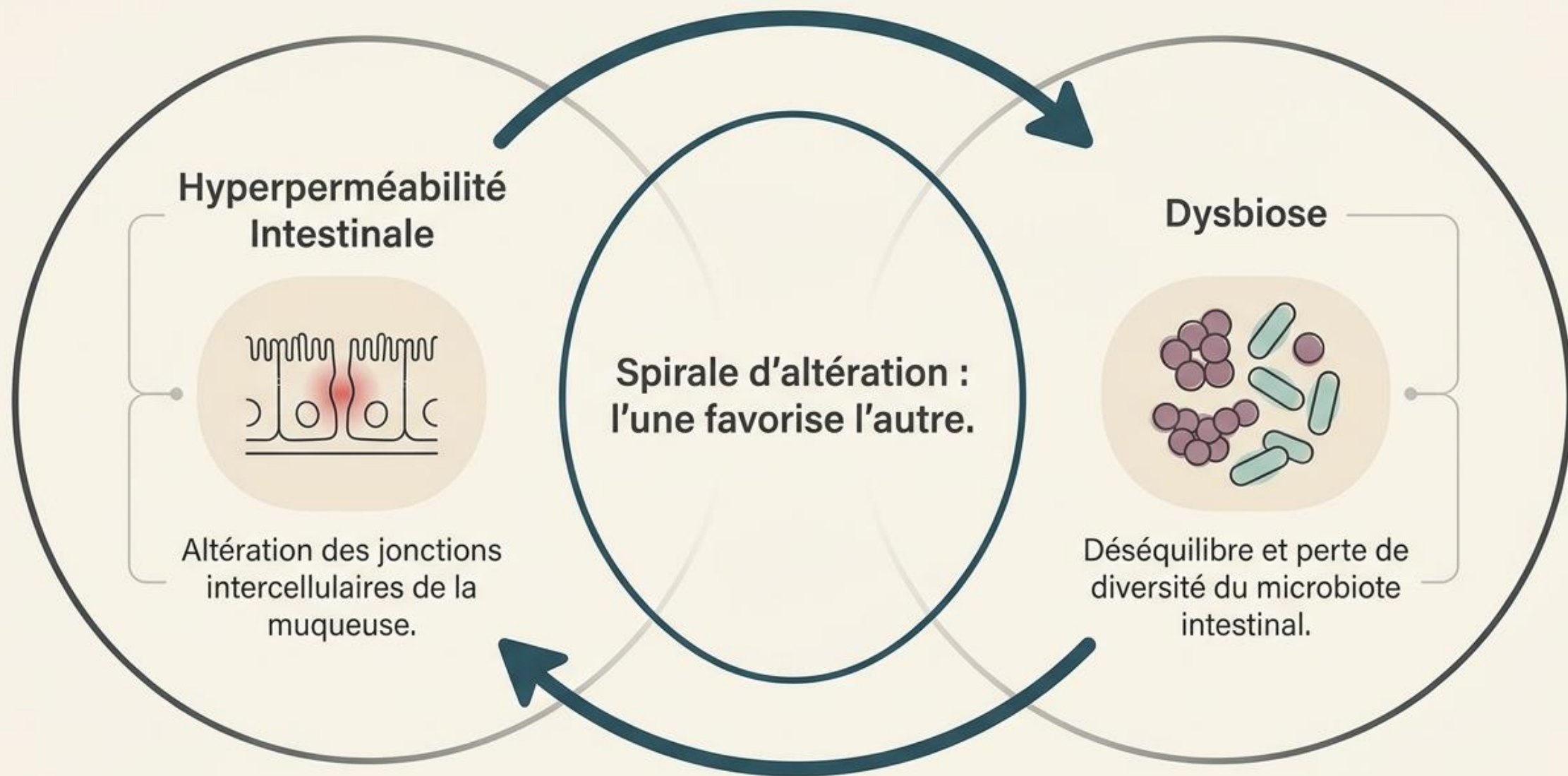


Entérocytes: Cellules absorbantes. Barrière sélective (desmosomes) laissant passer les micronutriments, bloquant les macromolécules.

Cellules Caliciformes: Sécrétion de mucus protecteur.

Cellules de Lieberkühn / Paneth: Sécrétion enzymatique et peptides antimicrobiens.

Chorion (Axe central): Contient le réseau capillaire sanguin et chylifère (lymphatique), ainsi que des fibres musculaires lisses pour raccourcir la villosité et pomper les nutriments.



Causes :

Agents infectieux

(Staphylocoques, streptocoques, colibacilles, salmonelles, Candida albicans)

Stress chronique

(Suractivation sympathique, adrénaline/cortisol entraînant une vasoconstriction)

Alimentation

(Produits transformés, IG élevé, graisses saturées, gluten, lait, excès de viande)

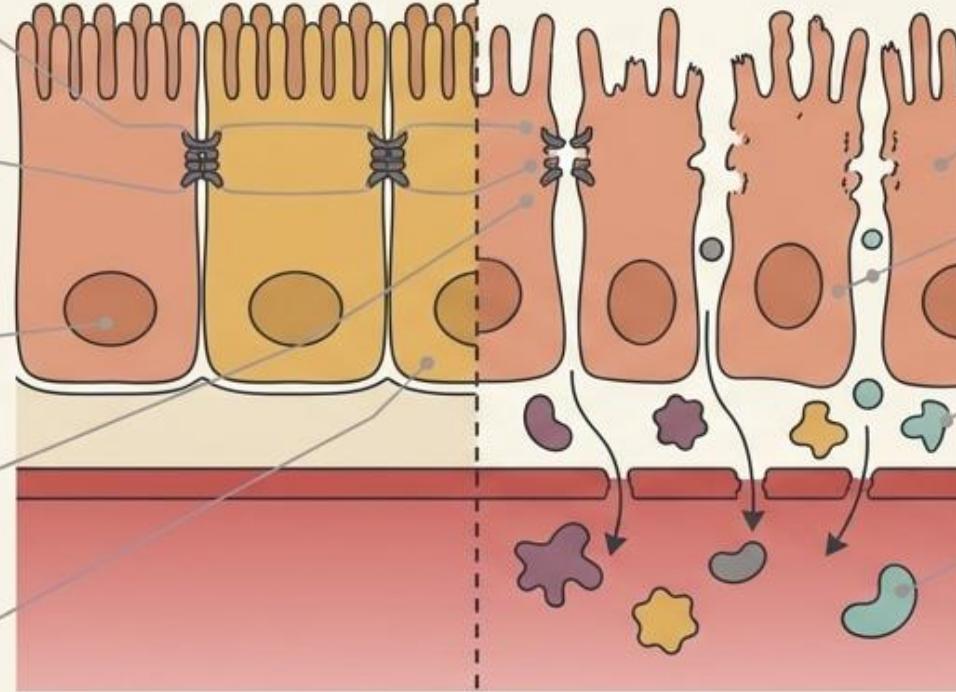
Effort extrême

(Sports d'endurance réduisant la perfusion splanchnique)

Médicaments

(AINS, salicylés, corticoïdes, antibiotiques, chimiothérapie)

Hyperperméabilité Intestinale



Conséquences :

Allergies

(Hypersensibilité aux antigènes)

Auto-immunité

(Réaction contre le « non-soi » atteignant d'autres tissus)

Carences

(Mauvaise absorption de vitamines, minéraux, acides gras)

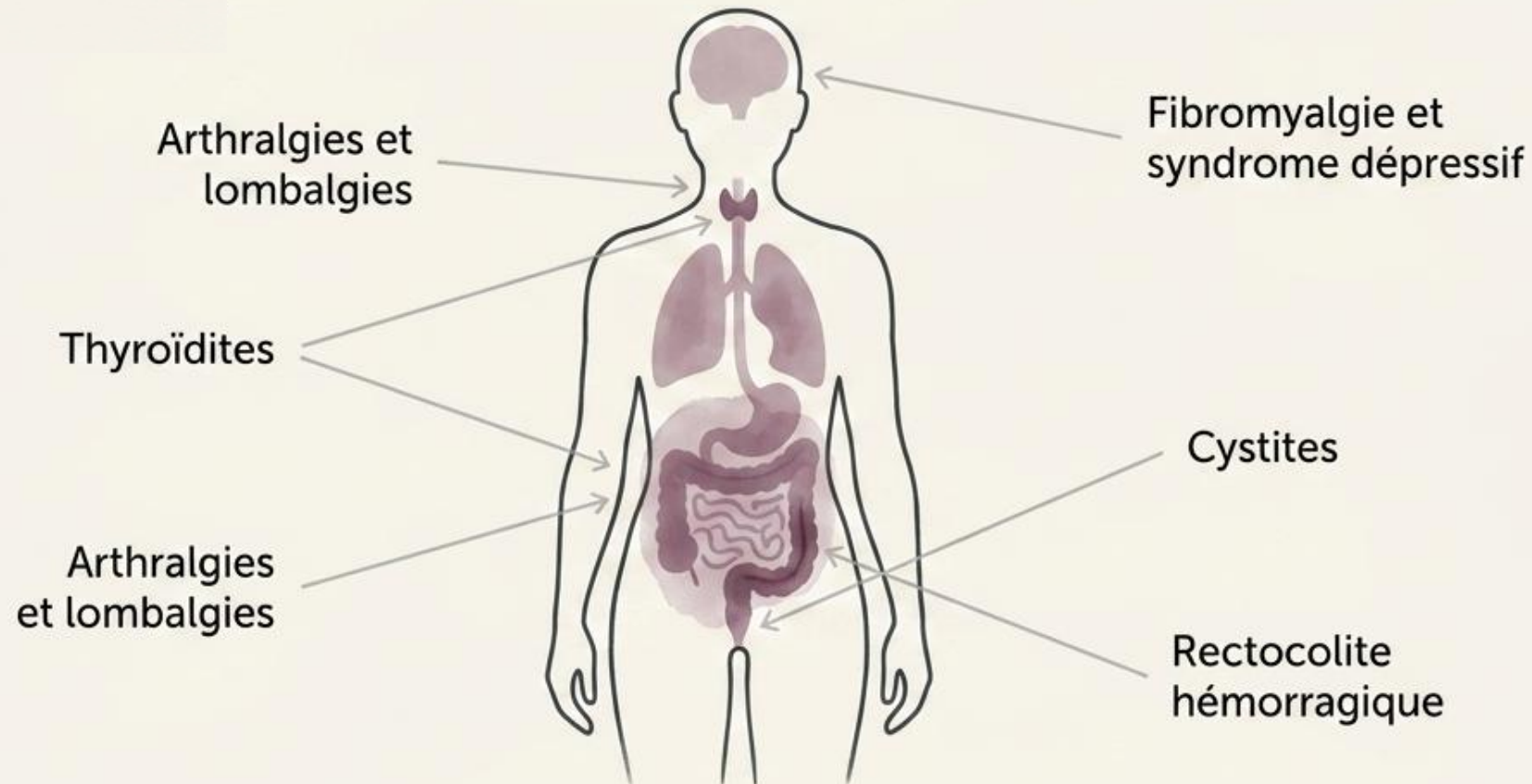
Surcharge hépatique

(Excès de toxines affluant vers le système porte)

Réflexion R.O.P. :

Face à des douleurs ou fixations ostéo-musculo-articulaires sans traumatisme évident, rechercher le lien avec une dysfonction viscérale.

Cartographie des Répercussions Systémiques



La dysbiose et l'hyperperméabilité ne restent pas confinées au tube digestif ; elles s'expriment à travers des pathologies systémiques et musculo-articulaires.

Matrice de Triage : Indications vs Exclusions

Prise en charge R.O.P.

Dysbioses : Troubles digestifs fonctionnels.

Suites de gastro-entérites : Persistance de troubles post-phase aiguë.

Entéroptoses : Tension anormale de l'intestin grêle, stases veineuses/lymphatiques, spasmes sympathiques.

Iléus paralytique : Inhibition de la motricité sur irritation péritonéale (dominante sympathique).

Signes d'Alerte (Urgence / Exclusion)

- Sang (rouge ou noir) dans les selles, vomissements.
- Fièvre, déshydratation, perte de poids inexpliquée.
- Douleur colique ombilicale aiguë, météorisme important.
- Occlusion intestinale (mécanique ou paralytique sévère).
- Hernie inguinale étranglée, épanchement intra-abdominal.
- Ganglion de Troisier (suspicion oncologique).

Maladie de Crohn

Maladie inflammatoire chronique modulée par la génétique, la dysbiose, l'environnement et l'émotionnel.

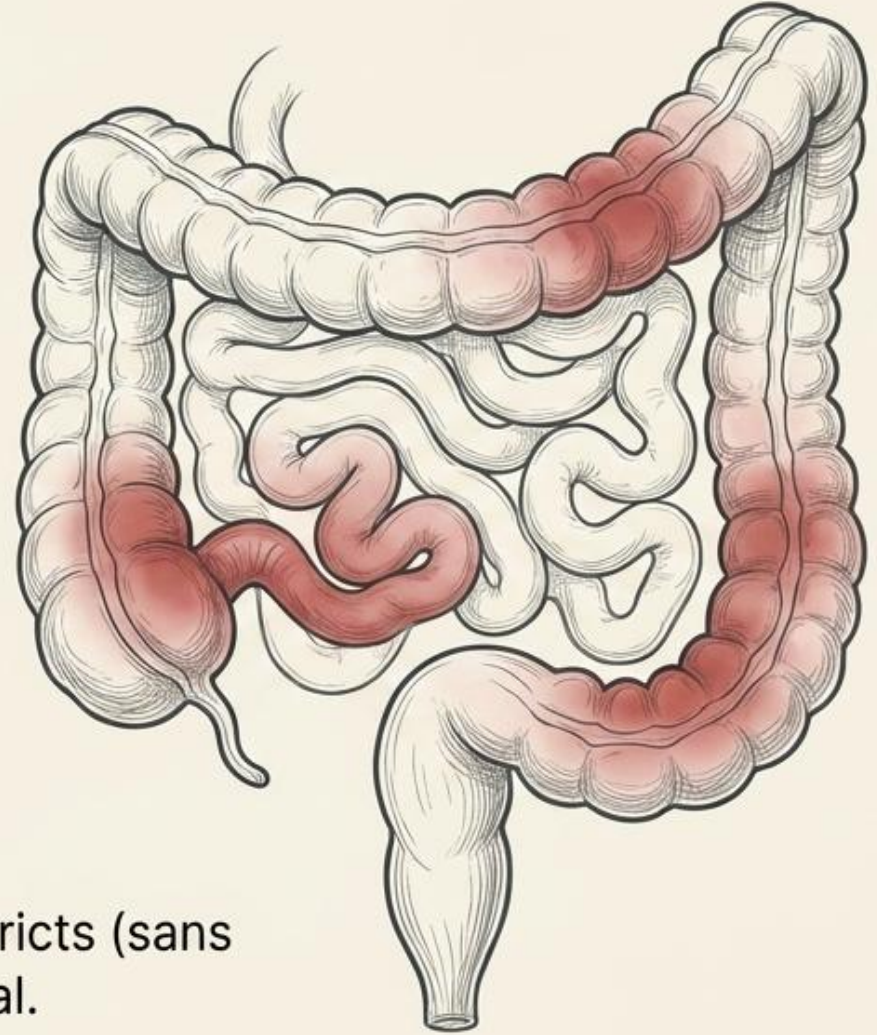
Symptomatologie

Diarrhées, douleurs abdomino-pelviennes, amaigrissement, asthénie.

Signes extra-digestifs

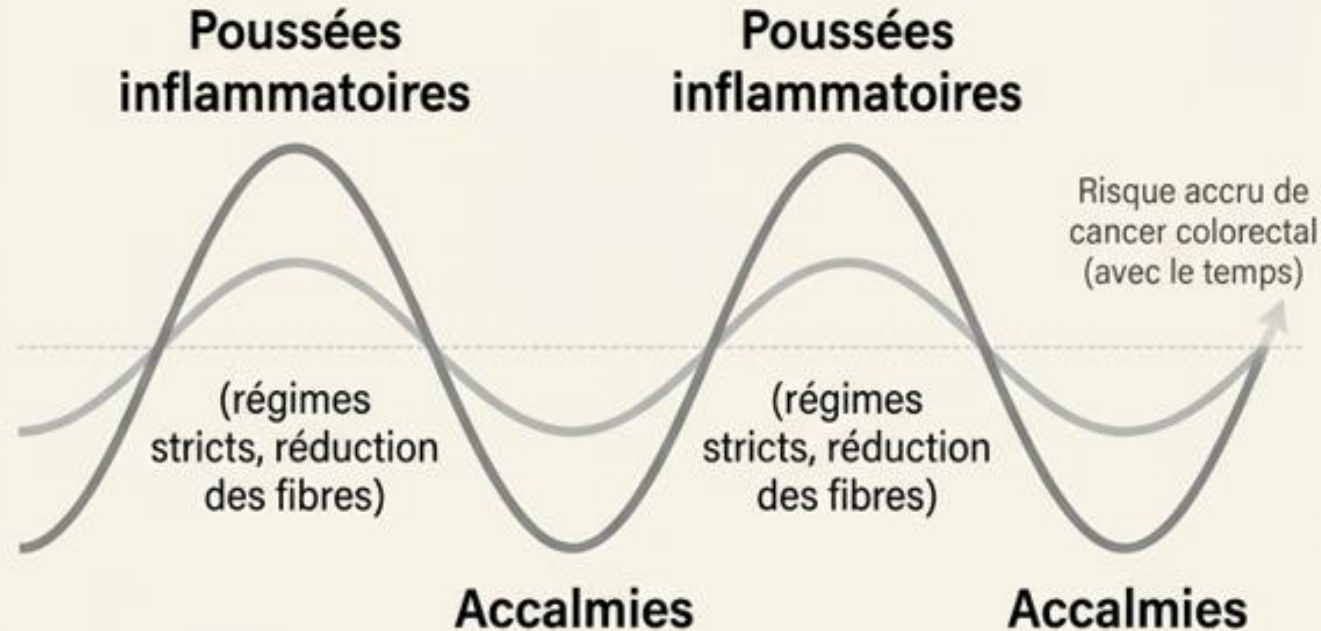
Aphtes buccaux, lombalgies, érythèmes noueux, atteintes pancréatiques, dépression.

Évolution : Progression par poussées/acalmies. Régimes stricts (sans fibres) parfois nécessaires. Risque accru de cancer colorectal.



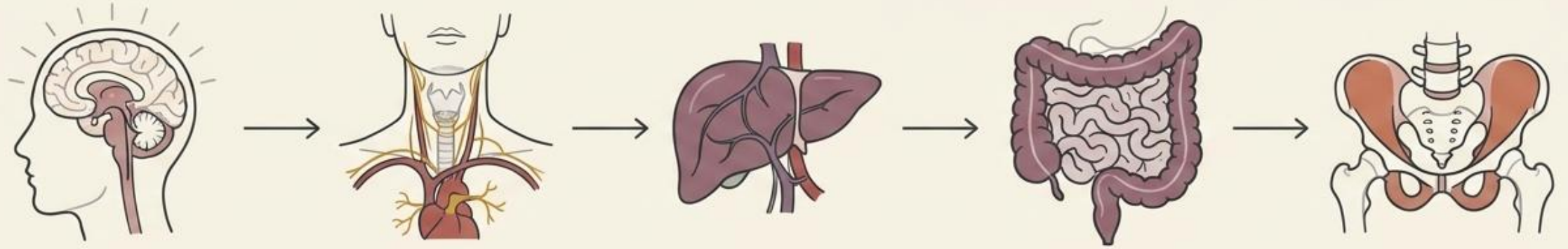
Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) : Crohn & RCH

Facteurs : Génétique, dysbiose, environnement, facteurs émotionnels modulant les poussées.



Protocole ROP : Ordre de Traitement

Aborder le terrain avant le symptôme local.



**Étape 1 : MRP
& Cerveau**
(Diencephale, Tronc
cérébral).

Étape 2 :
Système S.N.A.
(Équilibration du Nerve
Vague).

**Étape 3 : Foie
& Drainage**
(Soutien du métabolisme
et système porte).

Étape 4 : Intestin
Grêle & Côlon
(Motricité, anses jéjuno-
iléales, mésentère).

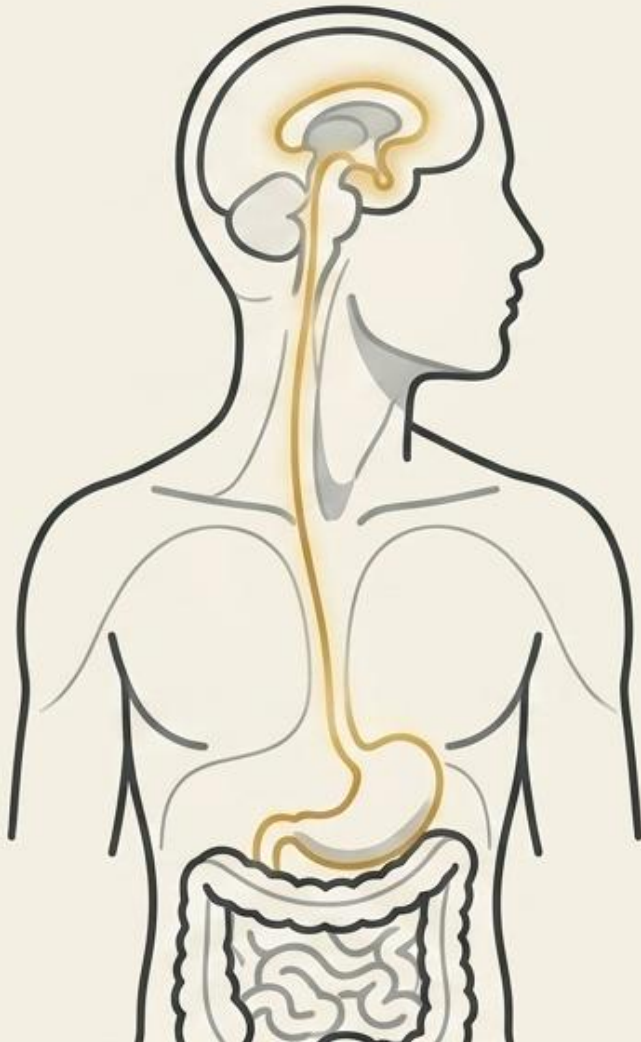
Étape 5 :
Ostéo-Articulaire
(Bassin, sacro-iliaques,
colonne).

Objectif

Soutenir les capacités de régulation du terrain sans se substituer au suivi médical allopathique.
Progression douce requise.

Profil Viscéro-Émotionnel : La 'Personne Intestin'

La muqueuse est lue en ROP comme un récepteur-émetteur d'émotions.



Signes Physiques

- Fatigue matinale
- Douleurs lombaires / genoux
- Troubles du transit
- Hypersensibilité aux fixations ostéo-musculaires

Traits Émotionnels

- Besoin viscéral de sécurité et de repères fixes.
- Hyperprotectrice envers les siens, méticuleuse.
- Anxiété souvent masquée par une assurance de façade ou de la logorrhée.
- Humeur changeante, facilement contrariée.